

Podłoże *biopsychospołeczne*

Cztery warstwy podatności: *geny, neurobiologia, psychika, środowisko*. Nie ma jednej przyczyny ChAD — jest wzajemne oddziaływanie wielu czynników, na które masz różny wpływ.

CZAS: 15 min — przeczytanie Po diagnozie, do powtórzenia

ŹRÓDŁO: Goodwin & Jamison (2007); Alloy & Abramson (2010)

JAK UŻYWAĆ

ChAD nie ma **jednej przyczyny**. Powstaje na styku czterech warstw: **biologicznej** (geny, neurobiologia), **psychologicznej** (wzorce myślenia, regulacja emocji, schematy), **społecznej** (wsparcie, role, status) i **środowiskowej** (stres, sen, używki, sezony). Każda z tych warstw ma swoje czynniki ryzyka i czynniki ochronne. Część z nich jest dana (geny), część w pełni Twoja (decyzje o lekach, śnie, używkach), część pośrednia.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Model *diateza-stres* wyjaśnia, dlaczego nie każdy z genetyczną podatnością zachoruje, i dlaczego stres prowadzi do epizodów u jednych osób, a u innych nie. Geny ustanawiają **próg** — biologiczną wrażliwość. Stresory środowiskowe i wzorce psychologiczne **aktywują** tę podatność lub ją uśpiają. Ważna konsekwencja: *nawet jeśli czynników biologicznych nie możesz zmienić, możesz zmienić znaczną część czynników psychologicznych i środowiskowych* — to one decydują o przebiegu choroby u konkretnej osoby. Wytlumaczenie „to genetyczne, więc nic nie zrobię” jest nieprawdziwe.

01 Cztery warstwy podatności i ochrony

BIOLOGIA

Geny: dziedziczność ChAD oceniana na 60–85% (jedne z najwyższych w psychiatrii). Bliźnięta jednojajowe: 40–70% zgodności.

Neurobiologia: zmienione szlaki dopaminy, glutaminianu, BDNF. Zmiany w korze przedczołowej, ciele migdałowatym, hipokampie.

Rytmu dobowe: zaburzona regulacja zegara dobowego (geny CLOCK, BMAL1).

PSYCHIKA

Schematy: perfekcjonizm, autonomia ekstremalna, schemat „jestem wyjątkowy/-a” mogą podtrzymywać hipomanię.

Regulacja emocji: tendencja do tłumienia lub eskalacji.

Wzorce myślenia: ruminacje (depresja), pozytywne uogólnienia („wszystko mi się uda” — hipomania).

SPOŁECZNOŚĆ

Sieć wsparcia: bliskie więzi obniżają stres przewlekły.

Role i status: utrata pracy, rozstanie — częste wyzwolacze. Awans też (więcej presji, mniej snu).

Kontekst rodzinny: wysoka emocjonalność wyrażana w rodzinie (krytyka, nadopiekuńczość) zwiększa ryzyko nawrotu.

ŚRODOWISKO

Sen i rytm dobowy: deprywacja snu — najsilniejszy modyfikowalny wyzwalacz manii.

Substancje: alkohol, kannabinoidy, stymulanty zaburzają rytm i biochemię.

Sezonowość: część osób ma cykl roczny (mania wiosną/latem, depresja jesienią/zimą).

02 Model diateza-stres — jak się to składa

Diateza (podatność) to **biologiczny próg** — Twoja indywidualna wrażliwość na rozregulowanie nastroju. Stres to **obciążenie środowiskowe** — wszystko, co wymaga adaptacji. Choroba ujawnia się, gdy obciążenie przekracza próg.

PRAKTYCZNE WNIOSKI Z MODELU

1. Jeśli masz wyższą podatność (silne obciążenie rodzinne), *nawet umiarkowane stresory* mogą wywołać epizod. To nie Twoja słabość — to fizjologia.
2. Możesz nie wpływać na próg, ale wpływasz na *obciążenie*: sen, używki, decyzje życiowe, rytm pracy.
3. Leki (zwłaszcza lit) **podnoszą próg** — biologicznie zmniejszają wrażliwość. Dlatego są podstawą leczenia.
4. Terapia **zmniejsza obciążenie** psychologiczne (przepracowanie schematów, lepsza regulacja emocji, plany zaradcze).
5. Najlepsze efekty daje *kombinacja*: lek (podnosi próg) + terapia (obniża obciążenie) + lifestyle (sen, rytm, abstynencja).

03 Co od Ciebie zależy, a co nie

NIE ZALEŻY OD CIEBIE

- Podłoże genetyczne i rodzinne
- Wiek pierwszego epizodu
- Typ ChAD (I, II, cyklotymia)
- Podstawowa wrażliwość biologiczna
- Część przebiegu choroby — zwłaszcza po latach

ZALEŻY OD CIEBIE

- Regularność leków i kontroli
- Sen i rytm dobowy
- Abstynencja od alkoholu i substancji
- Wykres nastroju, plan kryzysowy
- Terapia i praca z własnymi schematami
- Decyzje o stresorach (praca, związki)

04 Powszechne nieporozumienia

„TO MOJA WINA”

ChAD ma wyraźne podłoże biologiczne. Wybory wpływają na przebieg, ale nie na samo istnienie choroby.

„TO SŁABY CHARAKTER”

Charakter i ChAD to różne porządki. Wybitni naukowcy, artyści, sportowcy mają ChAD — to nie wyklucza dyscypliny ani osiągnięć.

„GENETYCZNE = NIEZMIENNE”

Nawet w 80% dziedzicznej chorobie pozostaje **znaczna część wpływu** środowiskowego — i to ona decyduje o przebiegu u konkretnej osoby.

„TYLKO LEKI” LUB „TYLKO TERAPIA”

Najlepsze wyniki daje **kombinacja**: lek + terapia + lifestyle. Każda warstwa działa na inny mechanizm.

Klucz: w długoterminowym badaniu Miklowitz i wsp. (2007) pacjenci ChAD korzystający *jednocześnie* z farmakoterapii i terapii rodzinnej mieli **o 35-50% niższe ryzyko nawrotu** w 2-letniej obserwacji niż pacjenci tylko na lekach. Model biopsychospołeczny nie jest filozofią — to przekład badań na praktykę. Każda warstwa, której dotykasz, realnie zmienia ryzyko.